



Kit de Comunicação Clínica com Psiquiatras

Modelos, roteiros e ficha de resumo clínico

Dra. Tatiana Gontijo

Kit de Comunicação Clínica com Psiquiatras

Dra. Tatiana Gontijo

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução parcial deste material apenas com citação da fonte.

ISBN digital: [a definir]

Edição: 1ª edição

Ano: 2026

Publicado no Brasil

Edição e distribuição

[Nome editorial / selo]

Contato: <https://dratatianagontijo.com.br>

Equipe técnica

Autoria: Tatiana Paranhos de Campos Gontijo

Diagramação: Thiago José Gontijo Cardoso

Sumário

ABERTURA

Introdução	4
-------------------	----------

CONTEÚDO CLÍNICO

Seção 1	Como se Comunicar com Clareza e Objetividade	5
Seção 2	Modelos de Mensagem por Cenário	7
Seção 3	Roteiros de Perguntas-Chave	15
Seção 4	Ficha de Resumo Clínico	17

Introdução

A mensagem já estava pronta na cabeça. O que você observou era claro: o paciente mudou, e o psiquiatra precisa saber. Mas quando a hora de escrever chegou, a dúvida apareceu. Como organizo isso em palavras? O que é mais relevante comunicar?

Este kit foi criado para esse momento. Você acompanha o paciente toda semana, conhece o padrão dele, percebe quando algo mudou. Essa observação tem valor clínico real. A questão é como transformá-la em comunicação clara, para que o cuidado integrado aconteça com mais precisão.

Na minha prática, vi quantas vezes a comunicação entre terapeuta e psiquiatra fez diferença no desfecho do caso. Não porque um sabia mais que o outro, mas porque cada um via o paciente de um ângulo diferente. Quando esses ângulos se encontram, o cuidado melhora.

O material está organizado em quatro seções: como estruturar uma comunicação clínica, modelos de mensagem por cenário, roteiros de perguntas para organizar a observação antes de escrever, e uma ficha de resumo clínico. Use o que for útil, adaptando ao contexto de cada caso.

Dra. Tatiana Gontijo

SEÇÃO 1: COMO SE COMUNICAR COM CLAREZA E OBJETIVIDADE

O que vale comunicar

Você ocupa um lugar único: vê o paciente toda semana, acompanha mudanças em tempo real e constrói um vínculo clínico próximo. Isso tem grande valor para o cuidado quando é comunicado com clareza.

Comunique:

- O que você observou diretamente (comportamento, fala, padrão)
- Mudanças em relação a sessões anteriores
- Falas literais do paciente que têm peso clínico
- Impacto funcional percebido (sono, trabalho, vínculos, risco)
- O que você está sentindo que precisa de atenção ou reavaliação

Não comunique:

- Diagnóstico fechado ("ele é bipolar")
- Sugestão de medicação específica ("deveria trocar para bupropiona")
- Certezas sobre causa ("é efeito colateral do remédio")
- Interpretações que ultrapassam sua observação clínica

A diferença na prática

Evita Invade a conduta	Prefira Organiza a observação
"Acho que ele está em mania."	"Paciente apresenta redução de sono sem cansaço, aceleração do pensamento e impulsividade com prejuízo financeiro."
"O escitalopram está causando embotamento."	"Desde o início da medicação, a reatividade emocional reduziu e a terapia perdeu profundidade."
"Precisa trocar de remédio."	"Solicito reavaliação: paciente considera interromper por conta própria."

Quando comunicar

Não espere a crise. Comunique quando:

- Perceber mudança de padrão relevante
- O paciente verbalizar intenção de parar o remédio
- Houver qualquer sinal de risco
- A terapia travar de forma que parece relacionada à medicação
- O paciente revelar algo que o psiquiatra precisa saber para conduzir bem o caso

Sobre confidencialidade

Compartilhe informações clínicas com o psiquiatra quando:

1. Há consentimento do paciente (preferencial: deixe isso combinado desde o início do tratamento)
2. Há risco relevante à vida ou à integridade do paciente ou de terceiros, e a comunicação é necessária para proteção

Em casos de risco, a proteção à vida pode prevalecer sobre o sigilo. Ainda assim, compartilhe apenas o necessário para proteger o paciente e sustentar a conduta.

Base ética para comunicar

O Código de Ética Profissional do Psicólogo protege o sigilo como regra. Também orienta que, no relacionamento com outros profissionais, sejam compartilhadas apenas informações relevantes para qualificar o cuidado. Quando houver conflito entre deveres éticos, o psicólogo pode decidir pela quebra de sigilo buscando o menor prejuízo e limitando a comunicação ao estritamente necessário.

Na prática:

- Combine previamente com o paciente como será a comunicação com psiquiatra e outros profissionais
- Peça autorização explícita sempre que possível
- Em risco iminente, acione a rede necessária mesmo sem autorização
- Compartilhe apenas dados relevantes para a proteção e continuidade do cuidado
- Registre no prontuário o motivo do contato, para quem comunicou, quando comunicou e o que foi comunicado

Estrutura básica de qualquer mensagem

1. **Quem é:** iniciais, idade, contexto mínimo
2. **O que você viu:** comportamento ou fala concreta, sem diagnóstico
3. **Quando mudou:** em relação a quando
4. **Impacto:** o que está sendo afetado (sono, trabalho, vínculo, risco)
5. **Pedido objetivo:** o que você precisa do psiquiatra

Termos técnicos úteis na comunicação clínica

- **Adesão ao tratamento:** quanto o paciente consegue seguir o plano combinado (medicação, horários e acompanhamento).
- **Latência terapêutica:** tempo esperado até a medicação começar a produzir benefício clínico.
- **Resposta parcial:** melhora presente, mas ainda insuficiente para recuperação funcional.
- **Remissão:** redução importante dos sintomas, com retorno mais estável do funcionamento.
- **Efeito colateral:** efeito indesejado associado ao tratamento, que pode impactar rotina e adesão.
- **Impacto funcional:** repercussão prática dos sintomas na vida diária (sono, trabalho, vínculos e autocuidado).
- **Descompensação clínica:** piora relevante do quadro em relação ao padrão recente do paciente.
- **Conduta:** plano clínico definido pelo profissional responsável pela prescrição.

SEÇÃO 2: MODELOS DE MENSAGEM POR CENÁRIO

Formato	Quando usar
Curto	WhatsApp profissional (2-3 linhas). Situação não urgente com contato direto.
Médio	Mensagem clínica organizada (1 parágrafo). Situações que exigem mais contexto.
Formal Atenção	E-mail ou encaminhamento escrito. Risco, diagnóstico diferencial ou documentação necessária.

Adapte sempre: substitua os campos em [colchetes] com os dados do seu paciente.

01. Início de antidepressivo sem melhora

Contexto: paciente com 2-4 semanas de uso relata que "não está funcionando" e considera parar.

Modelo curto:

"Paciente [iniciais], início de [medicação] há [x] dias. Sem resposta significativa ainda, mas sem piora. Adesão confirmada em sessão. Ideação ausente. Segue com [sintoma principal]. Tudo bem manter?"

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em uso de [medicação] há [x] dias por [diagnóstico]. Relata que não percebeu melhora e está considerando interromper por conta própria. Em sessão, confirmei adesão e ausência de ideação suicida. Sintomas atuais: [descrever]. Sem piora em relação ao início. Fiz psicoeducação sobre latência terapêutica. Solicito orientação para sustentar adesão até próxima consulta."

02. Suspeita de embotamento emocional

Contexto: paciente relata não sentir mais nada: nem tristeza nem alegria: após início ou ajuste de antidepressivo. Terapia trava.

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] relata melhora da tristeza, mas ausência de reatividade emocional desde início de [medicação]. Terapia com dificuldade de acesso afetivo. Solicito avaliação."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] semanas. Refere melhora do humor deprimido, mas apresenta embotamento afetivo significativo: ausência de prazer, distanciamento dos vínculos e redução de reatividade emocional em sessão. A terapia perdeu profundidade: paciente concorda intelectualmente mas sem acesso emocional. Solicito reavaliação de conduta."

03. Suspeita de virada maníaca Atenção

Contexto: paciente em uso de antidepressivo apresenta mudança abrupta de padrão: aceleração, redução de sono sem cansaço, impulsividade.

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] em uso de [medicação] há [x] semanas. Apresentou mudança abrupta: menos sono sem cansaço, aceleração, impulsividade. Solicito reavaliação urgente."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] semanas por episódio depressivo. Nesta semana apresentou mudança significativa de padrão: redução da necessidade de sono para [x] horas sem cansaço, aceleração do pensamento, [descrever comportamentos impulsivos]. Paciente refere sentir-se 'ótima': mudança inconsistente com baseline. Solicito reavaliação com urgência."

Modelo formal:

Prezado(a) Dr(a). [nome],

Encaminho atualização clínica de [iniciais], [idade] anos, em acompanhamento psicoterápico.

Paciente em uso de [medicação] há [x] semanas por episódio depressivo. Na sessão de [data], apresentou mudança abrupta de padrão em relação às semanas anteriores: redução da necessidade de sono ([x] horas sem cansaço), aceleração do pensamento e do discurso, [impulsividade: descrever comportamento concreto], e relato de sensação de estar "ótima": inconsistente com o perfil habitual da paciente.

A mudança de padrão merece reavaliação urgente, inclusive pela possibilidade de ativação maniforme. Solicito orientação de conduta.

Atenciosamente,

[seu nome]

04. Suspeita de risco suicida Atenção

Contexto: paciente verbaliza ideação passiva, ativa ou com plano. Nível de urgência varia.

Modelo curto (ideação passiva, sem plano):

"Paciente [iniciais] relatou ideação de morte passiva em sessão hoje: desejo de não acordar, sem plano estruturado. Sem ideação ativa ou acesso a meios. Aumentei frequência de sessões. Solicito orientação."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em sessão hoje relatou ideação de morte [passiva/ativa: descrever]. [Com/sem] plano estruturado. [Com/sem] acesso a meios. Funcionamento atual: [descrever]. Rede de apoio: [presente/ausente]. Adesão à medicação: [confirmar]. Solicito orientação para conduta e possível reavaliação antes da próxima consulta programada."

Modelo formal (risco iminente):

Dr(a). [nome]: situação urgente.

Paciente [iniciais], [idade] anos, verbalizou em sessão hoje plano suicida com intenção de ação. Relato: [descrever frase literal]. [Tem/não tem] acesso ao meio. [Familiar acionado/não acionado].

Paciente [permanece no consultório / foi acompanhado por familiar / foi encaminhado ao PS]. Solicito orientação imediata de conduta.

[seu nome]: [telefone]

05. Oscilação emocional: bipolar vs borderline Atenção

Contexto: paciente com instabilidade emocional intensa, diagnóstico incerto ou histórico de múltiplas medicações sem resposta.

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em acompanhamento psicoterápico. Apresenta instabilidade emocional intensa com oscilações rápidas: [descrever: horas, não dias]: associadas predominantemente a contextos relacionais. Histórico de [x] medicações sem resposta sustentada. Em sessão, observo padrão que pode ser relevante para diferenciar ciclagem de humor de instabilidade relacional. Solicito avaliação diagnóstica integrada."

Modelo formal:

Prezado(a) Dr(a). [nome],

Encaminho observação clínica de [iniciais], [idade] anos.

Em acompanhamento semanal, observo instabilidade emocional com oscilações de humor que ocorrem em horas: não em dias ou semanas: predominantemente precipitadas por conflitos ou percepção de abandono em relacionamentos. Histórico de [x] medicações com resposta limitada. Padrão de idealização e desvalorização presente no vínculo terapêutico.

Considerando o perfil observado em sessão, solicito reavaliação diagnóstica integrada, especialmente para diferenciar ciclagem de humor de instabilidade relacional persistente.

Atenciosamente,

[seu nome]

06. Suspeita de TDAH não diagnosticado

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] com queixa de ansiedade e resposta parcial a antidepressivos. Em sessão, observo dificuldade atencional desde a infância, desorganização crônica e procrastinação por dificuldade de ativação. Solicito avaliação diagnóstica considerando essa possibilidade."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em tratamento para ansiedade com [medicação]. Resposta parcial: tensão melhorou, mas sobrecarga funcional persiste. Em sessão, observo dificuldade atencional desde a infância relatada pela própria paciente, desorganização crônica, procrastinação por dificuldade de iniciação (não por desmotivação), esforço compensatório massivo para manter rotinas básicas, e ansiedade possivelmente secundária à disfunção executiva. Solicito avaliação diagnóstica considerando essa possibilidade."

07. Suspeita de TOC

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] com ansiedade. Em sessão, observo pensamentos intrusivos egodistônicos seguidos de comportamentos repetitivos para aliviar angústia. Resposta parcial ao tratamento atual. Solicito reavaliação diagnóstica e de conduta."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em tratamento para ansiedade com [medicação] há [x] semanas. Resposta parcial. Em sessão, observo um ciclo repetitivo: [descrever pensamento intrusivo] gera angústia intensa, aliviada temporariamente por [descrever comportamento repetitivo]. Paciente reconhece irracionalidade, mas não consegue interromper. Solicito reavaliação diagnóstica e de conduta."

08. Suspeita de TEPT

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] em tratamento para ansiedade sem resposta adequada. Em sessão, revelou evento traumático não investigado anteriormente. Padrão atual: hipervigilância, pesadelos, evitação: sugere TEPT. Solicito reavaliação."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em tratamento para [diagnóstico] com [medicação] há [x] meses. Resposta limitada. Em sessão, a paciente revelou pela primeira vez [evento traumático: descrever sem detalhes desnecessários] ocorrido há [x] anos. Sintomas atuais: hipervigilância constante, pesadelos recorrentes, evitação de estímulos associados ao evento e reatividade intensa: são consistentes com TEPT. Avalio que o quadro principal pode ser traumático, não ansiogênico. Solicito reavaliação diagnóstica e de conduta medicamentosa."

09. Possível acatisia

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] em início de [medicação] há [x] dias. Refere inquietação motora intensa, incapacidade de permanecer parada: diferente da ansiedade habitual. Iniciou após medicação. Solicito reavaliação pela possibilidade de acatisia."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] dias. Relatou piora na última semana, mas com padrão diferente da ansiedade prévia: inquietação predominantemente corporal, incapacidade de permanecer parada, desconforto interno sem conteúdo cognitivo ansioso. Sintomas iniciaram após início da medicação. Solicito reavaliação pela possibilidade de acatisia: paciente considera interromper tratamento por desconforto."

10. Sinais de psicose inicial Atenção

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em acompanhamento por ansiedade e isolamento. Nas últimas sessões, observo: discurso progressivamente mais vago, dificuldade de completar raciocínios, relato de 'sensação de que as coisas estão estranhas' e possíveis ideias de referência: [descrever]. Uso regular de [cannabis/substância se aplicável]. Solicito avaliação psiquiátrica urgente."

Modelo formal:

Prezado(a) Dr(a). [nome],

Encaminho avaliação clínica urgente de [iniciais], [idade] anos.

Paciente em acompanhamento semanal por ansiedade e isolamento social. Nas últimas [x] sessões, observo deterioração progressiva: discurso mais vago e tangencial, perda do fio do raciocínio no meio das frases, relato de estranhamento da realidade ("as coisas estão diferentes, não sei explicar"), e possíveis ideias de referência ([descrever]). Uso regular de [substância se aplicável].

Pelas mudanças observadas e pelo risco de agravamento, solicito avaliação com urgência.

Atenciosamente,

[seu nome]

11. Suspeita de condição orgânica

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] com [diagnóstico] sem resposta adequada ao tratamento. Apresenta sinais físicos associados: [descrever: queda de cabelo, formigamento, tremor, etc.]: que podem justificar avaliação médica. Solicito reavaliação considerando possível componente orgânico."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em tratamento para [diagnóstico] há [x] meses com resposta parcial. Em sessão, além dos sintomas emocionais, relata [sinais físicos: descrever]. A combinação de sintomas psiquiátricos com sinais físicos específicos sugere possível componente orgânico subjacente: [hipótese: hipotireoidismo / deficiência de B12 / hipertireoidismo / hiperprolactinemia]. Solicito avaliação e investigação laboratorial pertinente."

12. Dependência de benzodiazepínico

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] em uso diário de [benzo] há [x meses/anos]. Relata tolerância e dificuldade de interrupção. Solicito avaliação para plano de retirada gradual."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses de forma diária. Relata que o efeito diminuiu com o tempo (tolerância), dificuldade de ficar sem o remédio (sintomas de abstinência que interpreta como recaída), e possível impacto cognitivo: [descrever queixas de memória, lentidão]. Paciente não percebe padrão como dependência. Solicito avaliação para plano de desmame gradual supervisionado."

13. Disfunção sexual por medicação

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] em uso de [medicação] há [x] meses. Relata disfunção sexual significativa desde o início: [redução de libido / dificuldade erétil / anorgasmia]. Considera interromper. Solicito reavaliação."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses. Após construção de vínculo terapêutico, relatou disfunção sexual significativa desde o início da medicação: [descrever]. Impacto relevante na relação afetiva e na autoimagem. Paciente está considerando interromper o tratamento por conta própria. Solicito reavaliação de conduta: o abandono desassistido representa risco de recaída."

14. Polimedicação com piora global Atenção

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], [idade] anos, em uso de [listar medicações] prescritas por [x] profissionais ao longo de [x] anos. Apresenta fadiga crônica, prejuízo cognitivo, embotamento afetivo e ganho de peso: sintomas que podem estar relacionados à sobreposição de efeitos colaterais, não ao quadro primário. Solicito revisão integrada da prescrição por um único profissional."

Modelo formal:

Prezado(a) Dr(a). [nome],

Encaminho avaliação clínica de [iniciais], [idade] anos, em acompanhamento psicoterápico.

Paciente em uso concomitante de: [listar medicações, doses e tempo de uso]. Medicações prescritas por diferentes profissionais em momentos distintos, sem revisão integrada.

Em sessão, relata: fadiga desproporcional, prejuízo significativo de memória e concentração, embotamento afetivo e ganho de peso de [x] kg no período. A combinação de efeitos colaterais das medicações atuais pode estar produzindo ou agravando os sintomas que o tratamento visa tratar.

Solicito revisão integrada da prescrição com objetivo de simplificação e avaliação de necessidade real de cada medicamento.

Atenciosamente,

[seu nome]

15. Paciente quer parar a medicação: momento adequado

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] estável há [x] meses. Solicita avaliação para retirada gradual do antidepressivo. Bom suporte psicoterapêutico. Sugiro avaliarmos juntos a viabilidade."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses. Estável há [x] meses: funcional, sem recaídas, com bom suporte psicoterapêutico. Manifesta desejo de avaliar possibilidade de retirada gradual. Orientei que a decisão e o processo são médicos, e que a retirada deve ser gradual. Solicito avaliação conjunta para planejar desmame se indicado."

16. Paciente quer parar a medicação: momento inadequado

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] com [x] semanas de estabilização quer interromper [medicação]. Orientei sobre riscos. Solicito reforço da orientação sobre tempo mínimo de manutenção na próxima consulta."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses, com estabilização recente de [x] semanas. Manifesta desejo de interromper o tratamento: motivação: [descrever]. Orientei sobre o risco de recaída precoce e sobre o tempo mínimo de manutenção após estabilização. Paciente considerou, mas mantém desejo. Solicito que na próxima consulta seja reforçada a orientação sobre continuidade: o alinhamento médico-terapeuta aumenta adesão."

17. Paciente já parou a medicação por conta própria

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] interrompeu [medicação] abruptamente há [x] dias. Apresenta [sintomas: tontura, brain zaps, irritabilidade]. Orientei sobre síndrome de descontinuação. Solicito reavaliação urgente."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses, interrompeu abruptamente há [x] dias sem orientação médica. Apresenta em sessão: [descrever sintomas]. Quadro pode ser compatível com síndrome de descontinuação. Orientei retorno ao acompanhamento médico e não interpretei os sintomas como recaída sem avaliação. Solicito avaliação urgente."

18. Crise aguda em sessão Atenção

Modelo curto (urgente):

"Paciente [iniciais] em sessão agora. [Verbalização de plano suicida / Descompensação psicótica / descrever]. Solicito orientação imediata de conduta."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais] em sessão hoje apresentou [descrever crise]. [Familiar acionado / aguardando orientação / encaminhando ao PS]. Solicito contato urgente."

Modelo formal (documentação pós-crise):

Prezado(a) Dr(a). [nome],

Registro do ocorrido em sessão de [data]:

Paciente [iniciais] apresentou [descrever o que aconteceu: crise, verbalização, comportamento]. Conduta adotada: [descrever o que foi feito: familiar acionado, SAMU, encaminhamento ao PS, etc.]. Estado ao fim da sessão: [descrever].

Solicito alinhamento de conduta para os próximos passos.

[seu nome]: [telefone]

19. Suspeita de uso de substâncias

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] sem evolução em [x] meses de tratamento. Em sessão, revelou uso regular de [álcool/cannabis/cocaína: descrever padrão]. Possível interferência na resposta medicamentosa. Solicito reavaliação considerando esse contexto."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], em uso de [medicação] há [x] meses com resposta inadequada. Em sessão, após construção de vínculo, relatou uso regular de [substâncias: descrever: frequência, quantidade]. Paciente autorizou comunicação. O uso relatado pode estar interferindo na resposta ao tratamento. Solicito reavaliação considerando esse contexto."

20. Psiquiatra trocou ou ajustou a medicação: acompanhamento pós-mudança

Contexto: após troca ou ajuste de dose, terapeuta observa mudanças relevantes na sessão.

Modelo curto:

"Paciente [iniciais] após [troca de / ajuste de dose de] [medicação] há [x] dias. Observo em sessão: [descrever mudança]. Solicito orientação se esperado nessa fase."

Modelo médio:

"Paciente [iniciais], após [troca de medicação / aumento de dose para x mg] há [x] dias. Em sessão, observo as seguintes mudanças em relação ao período anterior: [descrever: agitação, sedação, humor, sono, comportamento]. Gostaria de saber se o padrão é esperado nessa fase de transição ou se merece atenção clínica. Isso me ajuda a orientar melhor o paciente nas sessões e saber o que monitorar."

21. Paciente resistente a buscar psiquiatra

Contexto: terapeuta percebe necessidade de avaliação psiquiátrica, mas paciente recusa ou ainda não tem psiquiatra.

Observação: esta situação envolve primeiro uma conversa com o paciente: não com o psiquiatra. Os modelos abaixo são para quando você precisa fazer um encaminhamento formal.

Modelo de encaminhamento escrito para o paciente levar:

"Encaminho [iniciais], [idade] anos, para avaliação psiquiátrica."

Paciente em acompanhamento psicoterápico desde [data]. Apresenta [descrever quadro clínico em linguagem simples]. Em sessão, observo [descrever o que justifica avaliação]. Avaliação psiquiátrica se faz necessária para [descrever objetivo: diagnóstico diferencial / possibilidade de medicação / revisão de conduta].

Agradeço contato para alinhamento de conduta.

[seu nome]: [contato]"

Modelo de abordagem para usar com o paciente antes do encaminhamento:

"Eu percebi algumas coisas nas nossas sessões que acho importante investigar com mais profundidade. Não estou dizendo que você precisa de remédio. Estou dizendo que faz sentido ter uma avaliação: assim a gente sabe o que está diante de nós e pode trabalhar melhor juntos. Você toparia ir uma vez, só para ouvir?"

SEÇÃO 3: ROTEIROS DE PERGUNTAS-CHAVE

Use estes roteiros antes de escrever ao psiquiatra. Eles ajudam a separar observação concreta, hipótese clínica e pedido objetivo.

1. Início ou troca de antidepressivo

- Quando a medicação começou? Houve aumento, redução ou troca recente?
- O paciente está tomando todos os dias? Em qual horário?
- O que mudou em sono, apetite, energia, ansiedade e funcionamento?
- Houve piora rápida, agitação, inquietação corporal ou ideação suicida?
- O paciente quer parar por impaciência, efeito colateral ou medo?
- O que é igual ao quadro inicial e o que apareceu depois da medicação?

2. Suspeita de embotamento emocional

- A tristeza diminuiu ou todas as emoções ficaram mais baixas?
- O paciente sente prazer, irritação, desejo, afeto e conexão?
- A vida está melhorando ou apenas ficou mais "neutra"?
- A terapia perdeu acesso emocional depois da medicação ou ajuste?
- O paciente está pensando em parar o remédio por se sentir anestesiado?

3. Suspeita de ativação ou hipomania

- O paciente está dormindo menos porque não consegue ou porque não sente necessidade?
- No dia seguinte, há cansaço ou energia aumentada?
- Há aceleração de fala, pensamento ou decisões?
- Houve gastos, conflitos, impulsividade sexual, projetos excessivos ou exposição a risco?
- Alguém próximo percebeu que ele está diferente?
- Essa mudança parece melhora estável ou uma mudança abrupta de padrão?

4. Trauma, dissociação ou TEPT

- Existe algum evento que o paciente evita tocar ou lembrar?
- Há pesadelos, flashbacks, hipervigilância ou sobressalto exagerado?
- O paciente evita lugares, pessoas, assuntos ou sensações corporais específicas?
- Quando dissocia, ele sabe onde está? Quanto tempo dura?
- O sintoma piora quando certos temas aparecem na sessão?
- O paciente autorizou que esse contexto seja mencionado ao psiquiatra?

5. Paciente quer parar a medicação

- Por que ele quer parar agora?
- Está estável há quanto tempo?
- Já tentou parar antes? O que aconteceu?
- A decisão vem de melhora real, efeito colateral, vergonha, medo ou pressão externa?
- Ele conversou com o psiquiatra antes de alterar dose ou suspender?
- O que precisa ser alinhado para não haver retirada abrupta?

6. Uso de substâncias

- Usa álcool, cannabis, estimulantes, calmantes sem prescrição, anabolizantes ou suplementos?
- Qual frequência, quantidade e contexto de uso?
- Usa para dormir, relaxar, render, socializar ou não sentir?
- O uso piora sono, humor, ansiedade, impulsividade ou adesão?

- O paciente contou isso ao psiquiatra?
- Ele autoriza que essa informação seja compartilhada?

7. Possível componente clínico/orgânico

- Houve mudança de peso, pele, cabelo, intestino, ciclo menstrual ou libido?
- Há tremor, palpitação, sudorese, formigamento, fraqueza ou tontura?
- O cansaço parece emocional, corporal ou os dois?
- O quadro não responde apesar de adesão e acompanhamento adequado?
- O paciente tem acompanhamento médico clínico recente?
- Faz sentido sugerir avaliação médica sem afirmar causa?

SEÇÃO 4: FICHA DE RESUMO CLÍNICO

Use esta ficha para organizar o que será compartilhado com o psiquiatra. Inclua apenas informações relevantes para a continuidade do cuidado.

FICHA DE RESUMO CLÍNICO

Paciente Iniciais	Idade	Data
Motivo do contato Por que estou escrevendo agora?		
Medicação atual conhecida Nome, dose e tempo de uso, se o paciente souber informar		
O que observei em sessão Comportamentos, falas, mudança de padrão e impacto funcional		
Falas literais do paciente Use aspas apenas para frases clinicamente relevantes		
Tempo de evolução do padrão Quando começou? Está piorando, melhorando ou oscilando?		
Sono	Trabalho/estudo	Vínculos
Urgência percebida [] Sem urgência imediata [] Alinhar em breve [] Urgente hoje		
Pedido objetivo ao psiquiatra Reavaliação, orientação de conduta, antecipação de consulta ou alinhamento		
Registre no prontuário o motivo do contato, para quem comunicou, quando comunicou e o conteúdo essencial.		